

Wczesne schematy *to bezpośredni produkt traumy dziecięcej*

Schema Therapy łączy CBT, Gestalt, teorię przywiązania. Identyfikuje 18 wczesnych nieadaptacyjnych schematów (EMS) i tryby. Częściowe rodzicielstwo (*limited reparenting*).

CZAS: 1,5-3 lata **REALIZACJA:** Faza 2 — przetwarzanie schematów

ŹRÓDŁO: Young, Klosko & Weishaar (2003, *Schema Therapy: A Practitioner's Guide*); Bamelis i in. (2014, RCT N = 323, ST > CBT > leczenie standardowe); Giesen-Bloo i in. (2006, RCT, ST > TFP w BPD: 52% kontra 29% remisji)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **najczęstsze schematy w C-PTSD:** defektywność/wstyd, porzucenie, nieufność, deprywacja emocjonalna, podporządkowanie, zahamowanie, porażka. W sekcji 02 — **cztery tryby** aktywowane w C-PTSD: zranione dziecko (*vulnerable child*), rodzic karzący (*punitive parent*), odłączony obrońca (*detached protector*), gniewne dziecko (*angry child*). Sekcja 03 — **twoja mapa schematów:** rozpoznanie wstępne. Sekcja 04 — pytania do specjalisty Schema Therapy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Schema Therapy (Young, Klosko & Weishaar, 2003) jest **integracyjnym podejściem** łączącym CBT, Gestalt, teorię przywiązania i psychodynamikę. W C-PTSD wczesne nieadaptacyjne schematy (EMS — *Early Maladaptive Schemas*) są **bezpośrednim produktem** traumy dziecięcej — niezaspokojone potrzeby przywiązaniowe generują głębokie przekonania o sobie i innych. **Schematy najczęstsze w C-PTSD:** defektywność/wstyd (centralny), porzucenie, nieufność, deprywacja emocjonalna — szczegółowo w tabeli na stronie 1. **Tryby schematowe w C-PTSD:** (a) *vulnerable child* — zranione, samotne, przestraszone dziecko (rdzeń patologii); (b) *punitive parent* — zinternalizowany głos sprawcy lub krytyka; (c) *detached protector* — odcięcie emocjonalne, dysocjacja; (d) *angry child* — wściekłość za niesprawiedliwość. Bamelis i in. (2014, RCT N = 323): Schema Therapy **skuteczniejsza** niż CBT i leczenie standardowe w zaburzeniach osobowości, niski wskaźnik porzucenia terapii. Giesen-Bloo i in. (2006, RCT): ST > TFP w zaburzeniu osobowości borderline (52% kontra 29% remisji). **Limited reparenting** (Young, 2003): terapeuta **częściowo** zaspokaja niezaspokojone potrzeby dziecięce pacjenta — ciepło, stabilność, walidację, granice, autonomię — **w granicach profesjonalizmu**. To **nie** jest wkroczenie w rolę rodzica, ale uznanie, że dla wielu pacjentów z C-PTSD relacja terapeutyczna jest **pierwszym** doświadczeniem stabilnej, przewidywalnej, ciepłej obecności. Praca z trybami obejmuje: rozpoznanie aktywnego trybu, dialog z trybami (techniki krzesła, *imagery rescripting*), wzmocnienie zdrowego dorosłego.

01 Najczęstsze schematy (EMS) w C-PTSD

SCHEMAT	GŁĘBOKIE PRZEKONANIE
Defektywność / wstyd	„Jestem wadliwy/-a, jeśli mnie zobaczą — odrzuca.” Centralny schemat w C-PTSD.
Porzucenie	„Každy, kogo pokocham, odejdzie. Bliskość prowadzi do utraty.”
Nieufność / nadużycie	„Ludzie mnie skrzywdzą — wykorzystają, zdradzą, oszukają.”
Deprywacja emocjonalna	„Nikt się mną nie zaopiekuje. Moje potrzeby emocjonalne nie zostaną zaspokojone.”

Inne częste schematy w C-PTSD: podporządkowanie („moje potrzeby się nie liczą”), zahamowanie emocjonalne („emocje są niebezpieczne”), porażka („nic mi się nie uda”).

02 Cztery tryby schematowe w C-PTSD

ZRANIONE DZIECKO (VULNERABLE)

Rdzeń patologii. Ranne, samotne, przestraszone dziecięce „ja”. Niesie ból traumy. Aktywuje się w sytuacjach przypominających dzieciństwo.

RODZIC KARZĄCY (PUNITIVE)

Zinternalizowany krytyk. Głos sprawcy lub krytycznego opiekuna. „Jesteś nic nie wart/-a, zasługujesz na karę”. Łączy się z wewnętrznym krytykiem (CFT).

ODŁĄCZONY OBROŃCA (DETACHED)

Dysocjacja, odcięcie emocjonalne. „Nic nie czuję”. Chroni przed bólem zranionego dziecka. Może uniemożliwiać terapię, jeśli dominuje.

GNIEWNE DZIECKO (ANGRY)

Wściekłość za niesprawiedliwość. „Mam prawo do gniewu”. W terapii ważne, by go nie tłumić — to często pierwsza zdrowa reakcja na traumę.

03 Moja mapa schematów + plan

MÓJ DOMINUJĄCY SCHEMAT

— defektywność / porzucenie / nieufność / deprywacja / podporządkowanie / zahamowanie; może być kilka; po czym poznaję

MÓJ NAJCZĘŚCIEJ AKTYWOWANY TRYB

— zranione dziecko / rodzic karzący / odłączony obrońca / gniewne dziecko; w jakich sytuacjach

PYTANIA DO SPECJALISTY SCHEMA THERAPY

— np. „czy planujesz pracę z trybami?”, „czy stosujesz *imagery rescripting*?”, „czy *limited reparenting*?”

CO MÓGŁBY OTRZYMAĆ MÓJ ZDROWY DOROSŁY DLA ZRANIONEGO DZIECKA

— ciepło, stabilność, walidację; konkretnie: jakie słowa, czyny

Klucz: Schema Therapy *nie* walczy ze schematami przez restrukturyzację — pracuje z nimi *doświadczeniowo*. *Imagery rescripting* (Arntz): pacjent wraca w wyobraźni do sceny z dzieciństwa, gdzie schemat się ukształtował, ale tym razem *dorośle „ja”* (lub terapeuta) *interweniuje* — chroni zranione dziecko, konfrontuje sprawcę, daje to, czego dziecko potrzebowało. To korekcyjne doświadczenie zmienia *emocjonalne* znaczenie sceny, nie tylko poznawcze. Bamelis i in. (2014, RCT N = 323): Schema Therapy *skuteczniejsza* niż CBT w zaburzeniach osobowości, z *niskim* wskaźnikiem porzucenia terapii. To kluczowe w C-PTSD, gdzie standardowe protokoły CBT mają wysokie *dropout*. *Limited reparenting* (Young) — terapeuta jako stabilna, ciepła, przewidywalna obecność — jest dla wielu pacjentów *pierwszym* takim doświadczeniem.

△ Praca z trybem zranionego dziecka jest aktywująca — może wywoływać silny smutek, gniew, retrospekcje. Schema Therapy wymaga specjalistycznego treningu (ISST — International Society of Schema Therapy) — pytaj specjalistę o certyfikat. Bez treningu „praca z trybami” może być powierzchowna i nieskuteczna. *Imagery rescripting* bezpośrednio z wczesnodziecięcymi wspomnieniami traumy nie powinien być stosowany bez solidnej Fazy 1.